

自然分娩与剖宫产子宫复旧临床情况分析

夏琼

【摘要】 目的 探讨自然分娩与剖宫产子宫复旧情况的临床差异。方法 实施剖宫产产妇 200 例作为观察组,另选择同期实施自然分娩产妇 200 例作为对照组。测量两组产妇产后子宫底下降高度,分别在产后的第 1、3、5 天进行测量。观察两组产妇恶露持续时间情况,记录产后 6 周内恶露干净例数以及子宫复旧情况。结果 观察组产后不同时间的子宫底下降高度低于对照组,差异有统计学意义 ($P<0.05$)。观察组产妇产后 6 周恶露干净所占比例低于对照组,差异有统计学意义 ($P<0.05$)。观察组产妇产后 6 周子宫复旧良好所占比例低于对照组,差异有统计学意义 ($P<0.05$)。结论 剖宫产产妇产后的子宫复旧速度较自然分娩的子宫复旧速度慢,且恶露持续时间较自然分娩长,必须把握好剖宫产适应证,减少剖宫产率。

【关键词】 剖宫产 ;自然分娩 ;子宫复旧 ;恶露

DOI :10.14163/j.cnki.11-5547/r.2015.31.209

随着剖宫产率上升,对剖宫产后子宫复旧方面的研究也逐渐增多。而剖宫产后子宫复旧和相关并发症方面的研究也引起临床医生的关注^[1-3]。自然分娩后子宫复旧方面的问题研究已经明确,但剖宫产术后子宫复旧方面的问题认识较为模糊。本文选择在本院实施剖宫产和自然分娩的产妇,观察两种不同分娩方式下的子宫复旧情况,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择 2013 年 1 月~2015 年 1 月本院收治的实施剖宫产产妇 200 例作为观察组,另选择同期在本院实施自然分娩产妇 200 例作为对照组。观察组产妇平均年龄 27.4 岁,对照组产妇平均年龄 26.9 岁;观察组平均孕周 38.2 周,对照组平均孕周 38.3 周;观察组平均孕次 2.4 次,对照组平均孕次 2.5 次。两组均排除合并有子宫肌瘤、子宫畸形产妇。两组产妇一般资料比较,差异无统计学意义 ($P>0.05$),具有可比性。

1.2 方法 观察组产妇实施剖宫产,对照组产妇实施自然分娩。两组产妇产后均给予相关抗生素预防感染等,均实施母乳喂养。两组产妇均为产后出血等并发症,均无产褥感染等。测量两组产妇产后子宫底下降高度,分别在产后的第 1、3、5 天进行测量。观察两组产妇恶露持续时间情况,记录产后 6 周内恶露干净例数。观察两组产后 6 周的子宫复旧情况,子宫收缩良好,自然恶露干净,为子宫复旧良好;否则为子宫复旧不良。

1.3 统计学方法 采用 SPSS17.0 统计学软件对数据进行统计分析。计量资料以均数 $\pm$ 标准差 ($\bar{x} \pm s$) 表示,采用 t 检验;计数资料以率 (%) 表示,采用 χ^2 检验。 $P<0.05$ 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组产妇产后子宫底下降高度测量结果比较 观察组产后第 1 天子宫底下降高度为 (-0.94 ± 0.22) cm、产后第 3 天子宫底下降高度为 (2.17 ± 0.34) cm、产后第 5 天子宫底下降高度为 (2.27 ± 0.36) cm;对照组产后第 1 天子宫底下降高度为 (-1.22 ± 0.24) cm、产后第 3 天子宫底下降高度为 (3.36 ± 0.29) cm、产后第 5 天子宫底下降高度为 (3.27 ± 0.25) cm;观察组产后不同时间的子宫底下降高度低于对照组,差异均

有统计学意义 ($P<0.05$)。

2.2 两组产妇产后 6 周恶露持续情况比较 观察组产妇产后 6 周内恶露干净共 121 例,占 60.5%,其余 79 例产后 6 周内恶露未净,占 39.5%。对照组产妇产后 6 周内恶露干净共 184 例,占 92.0%,其余 16 例产后 6 周内恶露未净,占 8.0%。观察组产妇产后 6 周恶露干净所占比例低于对照组,差异有统计学意义 ($P<0.05$)。

2.3 产后 6 周两组产妇子宫复旧良好情况比较 观察组产妇产后 6 周内复旧良好共 161 例,占 80.5%,39 例产后 6 周内子宫复旧不良,占 19.5%。对照组产妇产后 6 周内复旧良好共 183 例,占 91.5%,17 例产后 6 周内子宫复旧不良,占 8.5%。观察组产妇产后 6 周子宫复旧良好所占比例低于对照组,差异有统计学意义 ($P<0.05$)。

3 讨论

产妇剖宫产分娩或自然分娩后,进入哺乳时期为产褥期,产妇机体器官恢复到未孕前的状态^[4-6]。胎盘娩出后,子宫要逐渐恢复到非孕状态,此过程即为子宫复旧。子宫复旧的过程是子宫肌纤维恢复到非孕状态,同时子宫内膜开始再生。产后子宫复旧受多种因素影响,分娩方式(剖宫产和自然分娩)及喂养方式(是否母乳喂养等)是主要的影响因素^[7-9]。在相同的喂养方式下,不同的分娩方式对子宫复旧的影响起着主要作用^[10]。研究表明,子宫肌纤维的收缩在子宫复旧中起着重要作用,若影响子宫复旧可导致子宫复旧不良^[11-13]。本文中,观察组和对照组产后不同时间测量子宫底下降情况,结果显示,观察组和对照组产后第 1 天的子宫均未下降,子宫底均上升,观察组产后的第 3 天和第 5 天子宫底下降高度开始增加,观察组子宫底下降速度低于对照组 ($P<0.05$),说明剖宫产术后产妇产后子宫复旧速度慢。观察组恶露持续时间长于对照组的恶露持续时间 ($P<0.05$),说明剖宫产术会影响到分娩后的子宫复旧。再者,对两组子宫复旧良好情况进行评定,观察组子宫复旧良好所占比例低于对照组 ($P<0.05$)。

综上所述,剖宫产影响到患者的子宫复旧速度,且恶露持续时间较自然分娩长,必须把握好剖宫产适应证,减少剖宫产率。

· 康复医疗 ·

精神康复中心对精神病患者回归社会的影响

李海鸽

【摘要】 目的 探索精神康复中心对精神病患者康复回归社会的影响。方法 20例进行精神康复的患者,进行为期6~12个月的康复中心模式的康复训练观察,观察回归社会率。结果 经过康复中心的系统康复训练,回归社会率为90%。结论 康复训练有助于稳定患者病情,提高患者生活质量,提高患者自知力,激发患者生活欲望,提高对外界适应能力,且精神康复中心独有的施资力量,专业的康复特点对精神病患者后期康复回归社会是近年来精神卫生事业的发展方向。

【关键词】 康复中心;精神病患者;回归社会

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2015.31.210

随着社会的进步,经济的发展,人们生活水平的提高,无形中产生了各种各样的心理压力,使得近年来精神病的发病率明显增高。精神病是一种持续的、反复发作的严重疾病,常起病于青壮年,多发于16~40岁,该疾病无明显器质性改变,为一种功能性精神病,以思维、情感、意志和行为障碍及精神活动与环境的不协调为主要特征^[1]。患者在长期住院及病症影响下,逐渐失去了社会功能。康复训练是恢复精神病患者社会功能的重要途径之一,可帮助患者激发生活欲望,提高生活质量,利于早日康复回归社会。本院自2010年在州残联的大力支持下建立了精神康复中心,得到了良好的社会反馈。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2014年在本院精神康复中心进行精神康复的20例患者进行了为期6~12个月的康复训练观察,所有研究对象均符合ICD-10精神疾病诊断标准的康复期患者。其中精神分裂症7例,抑郁症5例,躁狂症5例,神经症3例;女12例;男8例,文化程度:大学以上3例;高中10例;初中以下7例;年龄17~50岁,病程5个月~20年。20例康复训练患者由家属陪同或自行来到康复中心进行规范康复训练,此次调查研究在家属知情同意并签字积极配合下进行。

1.2 方法

1.2.1 本院建立了300多平方米的精神康复中心,室内环境宽敞、整洁、明亮,设施齐全。设有运动区:包括跑步机、健身自行车、仰卧板、健身椅等健身器材,还有乒乓球、台球。美工区:包括十字绣、折纸、中国结、插花等。园艺区:各种绿花草,全部由患者来栽培。读书区:各种图书、杂志。职业体验区;另设有两间单独训练室;还有休息室。配备专业护士多名,负责患者的康复训练,每周1次由专业医生对康复患者进行评估,由残联大力出资为康复患者提供营养丰富的午餐,为患者的康复创造了良好条件。本中心内相互以老师、学员互称,不存在患者、医生、护士,做到互敬互爱,相互学习,共同进步。

1.2.2 康复训练内容:①星期一,在老师的带领下集体参与对本中心进行全面清洁,保持环境清洁、明亮,让每位学员都能体会到集体感,养成干净整洁的习惯,体验到付出劳动所带来的幸福感。9:30准时在大厅内开展家庭会,由学员轮流主持,能力差的学员由老师辅助主持,共同分享上周六、日的新闻、趣事、家庭作业、所见所闻,也可以对这段时间的重要事件进行讨论,畅所欲言,增强学员对生活对社会的责任感。②星期二,进行区域活动,根据学员喜好,由专区老师负责进行系统的区域训练,如运动区:由于服用精神类药物体重增加,为了学员能够控制体重,保持良好的外观形

作者单位:133000 吉林延边脑科医院

参 考 文 献

- [1] 李春梅,刘婷,王若光,等.产后子宫复旧不良的中西医结合研究.湖南中医药大学学报,2008,28(6):13-15.
- [2] 肖娟,张海燕,张琳琳,等.产后子宫复旧不良发生现状分析.中国社区医师(医学专业),2010,5(27):42-43.
- [3] 黄益平.产后子宫复旧不全的中医药防治进展.河南中医,2012,4(1):124-126.
- [4] 李瑞兰,吕玲,黄益萍,等.芪母生化汤促进剖宫产术后患者子宫复旧192例临床观察.中医杂志,2012,6(5):407-409.
- [5] 黄敏玲.产妇产后康复综合治疗仪治疗对泌乳、产后子宫复旧的影响分析.吉林医学,2012,7(13):2741-2742.
- [6] 左燕,陈丽宏,谢人明.试论中成药子宫复旧促进剂的概念、分类及临床应用.中国医院药学杂志,2011,3(12):1014-1016.
- [7] 伍军容.剖宫产与自然分娩子宫复旧情况的比较.基层医学论坛,2015,8(5):616-617.
- [8] 陆露,李成志.子宫复旧不良治疗的研究进展.医学综述,2015,10(4):643-645.
- [9] 柳树芝.妇产康复治疗对促进子宫复旧的影响分析.中国医药指南,2015,8(9):177-178.
- [10] 雷国冰.产后康复综合治疗仪对乳汁分泌、子宫复旧的效果观察.广西医学,2009,5(6):890.
- [11] 李蘋.影响产妇产后子宫复旧的相关因素分析.中国农村卫生事业管理,2009,7(12):941-942.
- [12] 王琼林,付国芳,王梅.益宫颗粒促进子宫复旧及泌乳的临床分析.中国医药导报,2013,3(15):111-113.
- [13] 梁丽凌,杨贻钧.改良新式剖宫产术对初产妇子宫复旧的影响.中国现代手术学杂志,2005,9(2):146-148.

[收稿日期:2015-07-09]